

Información Paciente

Nombre : Manuel Alberto Rubio Fuentes
Edad : 65a 9m 12d
Dirección : Estero Piuquencito 0859

Rut : 7.726.468-K
Fecha Nacto: 07/05/1956
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1706162
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7150 4004

N° Epicrisis
296447

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Utim

Fecha Ingreso : 14/02/2022 21:02
Fecha Egreso : 19/02/2022 16:02

Días Estadía : 5

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

precordialgia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS PAM 2- 19/02/22

FI CASR: 14-02-2022
FI UCI: 15-02-2022
FI UTIM: 17-02-2022

Antecedentes:

- Mórbidos: (-)
- Quirúrgicos: (-)
- Fármacos: (-)
- Alergias: (-)
- Hábitos: TBQ activo 20 cig día hace 20 años, OH ocasional, Drogas (-)
- Social: jubilado
- Inmunizaciones: completo + 1 refuerzo

Motivo de Consulta: dolor torácico

Historia de ingreso:

Paciente sin antecedentes mórbidos consulta en el SU por cuadro de una hora de evolución de dolor torácico retroesternal que describe como ¿si lo estuvieran raspando?. Asociado a sensación de calor y sudoraciones. Sin náuseas ni vómitos ni irradiación. En sala de SU colapsa por lo que ingresa a reanimador en PCR presenciado. Se inicia RCP avanzado, Ritmo de PCR en FV. Sale a ROSC al 2do ciclo, con 2da desfibrilación a energía máxima. EKG de salida con SDST en pared anterior extenso, aparentemente sin Shock. Evaluado por UCO, historia de 24 horas de angina intermitente. Se gestionó Angioplastia de urgencia previa protección de vía aérea.

->CRNG= Estenosis de ADAm 90-95%, PCI con DES. Ventriculografía con FEVI de 50%. Hipoquinesia de apex y anterolateral. Sin insuficiencias ni gradientes valvulares.

Ingresa a UCI para continuar manejo.

Fecha Epicrisis : 19/02/2022 16:32

Fecha Última Actualización: 19-02-2022 16:32:49

Página 2 de 3

EVOLUCION CLINICA:

Hemodinamia: al ingreso UPC en contexto post PCR por IAMCSDST en pared anterior, en estatus post PCI; con requerimientos de DVA en dosis bajas titulando para PAM >65, en relación a sedoanalgesia la cual logra suspender precozmente. Con soporte BIC de amiodarona por episodio de FV previa asociada a IAM. Completó carga EV de AMD y posterior traslape oral + doble antiagregación y dosis altas de estatinas.

->Mantenía FC peri 90, por lo que se ajustó tto el 18/02 con adición de BB en dosis bajas (Bisoprolol 2.5 mg/día, con buena respuesta clínica.

->Pefil CV 18/02= TSH 1.6, Colesterol total 159 mg/dl, HDL 37 mg/dl, LDL 92 mg/dl, Tgs 149 mg/dl, HBA1C 5.0%.

Ventilatorio: sin conflicto de intercambio, extubado precozmente el 15/02 PM sin inconvenientes, con salida a soporte CNAF que rápidamente logra suspender hasta consolidar weaning el 17/02.

Medio interno: sin antecedentes de falla renal previa, se pesquisa hipokalemia severa de 2.5 que es corregido posteriormente.

Rehabilitación: post extubación evoluciona sin delirium, ni conflicto motor. Evaluado por FNA autoriza régimen VO desde el 16/02.

DX DE EGRESO:

Estatus post PCR -> ROSC

FV con compromiso Hemodinámico

SCACEST-> IAM reciente en región anterior

CC-> Enfermedad severa de 1 vaso -> ADAm estenosis 95% (FE 50%)

PCI a ADAm con DES (14/02/22)

AM-> Tabaquismo

Diagnóstico de Egreso

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

PA 110/80 FC 69x₂ FR 20x₂ SatO₂ 100%

Consciente, orientado T-E. Vigil. CRT 3₂, tibio a distal. Yugulares planas. Sin UMA. MV +, SRA. Rs Cs Rs sin soplos. Abdomen plano rs hs +, blando, sin megalias. EEII sin edemas ni signos de TVP.

Plan Post Alta

->Reposo Relativo

->Régimen hiposódico

->Losartan 50 mg vo 1 vez al día 7am.

->Amiodarona 200 mg vo 1 vez al día 9am

->Bisoprolol 2.5 mg vo 1 vez al día 3pm

->Ácido Acetilsalicílico 100 mg vo 1 vez al día con almuerzo

->Clopidogrel 75 mg vo 1 vez al día 5 pm

->Atorvastatina 80 mg vo 1 vez al día 8pm

->Control y seguimiento en CDT Cardiología.

->Acudir a Servicio de Urgencia SOS -> Palpitaciones, dificultad respiratoria, dolor torácico.

->Cese Tabaquismo.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

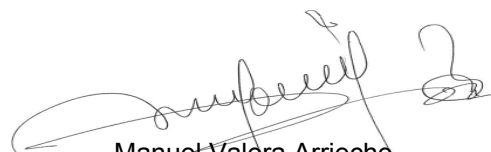
Fecha Epicrisis : 19/02/2022 16:32

Página 2 de 3

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Manuel Valera Arrieche
Médico Tratante (Staff)